



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PROPOSAL
INHOUSE CLINIC
Exclusive Elderly Care Center
2026

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa pengelolaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat diarahkan pada pengembangan dan peningkatan kemampuan agar upaya kesehatan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Di dalam upaya kesehatan, masyarakat dapat berperan baik sebagai perorangan maupun terorganisasi dalam berbagai bentuk dan tahapan pelayanan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang menjadi ujung tombak pembangunan kesehatan adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama (*primary health service*) berfungsi sebagai pelayanan kesehatan yang bersifat pokok (*basic health services*), yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Umumnya pelayanan kesehatan pada tingkat pertama ini bersifat pelayanan rawat jalan (*out patient services*). Pada pelayanan kesehatan tingkat pertama ini umumnya lebih banyak menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat (promotif dan preventif).

Selain itu masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya. Pihak swasta sangat diharapkan bisa menjadi mitra pemerintah yang dapat mengambil bagian secara aktif memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Olehnya itu klinik perusahaan merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan dasar yang potensial untuk dikembangkan. Perusahaan sebagai salah satu unsur masyarakat yang peduli dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, khususnya kepada pekerjanya melalui program pendirian klinik di perusahaan masing – masing.

Dengan program ini sebagai pusat perawatan eksklusif, meminimalkan mobilitas pasien ke rumah sakit luar untuk tindakan medis dasar (seperti perawatan luka, pemberian obat rutin, atau konsultasi ringan) adalah bentuk keunggulan layanan. Hal ini mengurangi stres pada lansia akibat perjalanan jauh dan memastikan mereka mendapatkan perawatan dalam lingkungan yang sudah familiar dan nyaman bagi mereka. Seiring dengan pertambahan usia, terjadi penurunan fungsi fisiologis yang signifikan serta peningkatan risiko penyakit degeneratif dan komorbiditas (seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung). Populasi lansia di pusat perawatan eksklusif membutuhkan pemantauan medis

yang jauh lebih intensif, teratur, dan berkelanjutan dibandingkan populasi umum guna mendeteksi dini setiap perubahan kondisi kesehatan.

Dalam perawatan lansia, kecepatan respons medis adalah kunci utama keselamatan. Kehadiran *in-house clinic* dengan tenaga perawat yang berjaga 24 jam serta ketersediaan dokter memastikan penanganan gawat darurat dapat dilakukan secara instan. Hal ini krusial untuk memenuhi standar *golden period* pada kasus serangan jantung atau stroke yang sering terjadi pada usia lanjut.

1.2 Tujuan

1. Tujuan Umum:

Menjamin Keselamatan dan Respon Medis Cepat Menyediakan layanan medis yang siap siaga 24 jam untuk menangani kondisi gawat darurat secara instan, guna memastikan penghuni mendapatkan penanganan pada masa krusial (*golden period*) tanpa harus menunggu transportasi ke rumah sakit luar.

2. Tujuan Khusus:

- a. Pemantauan Kesehatan Kontinu: Melakukan pemeriksaan fisik harian (*daily check-up*) secara personal untuk mendeteksi dini perubahan kondisi klinis pada lansia.
- b. Keamanan Medis 24 Jam: Menjamin kehadiran tenaga medis (Perawat) dalam dua *shift* penuh untuk memberikan rasa aman kepada penghuni, terutama pada jam-jam rawan di malam hari.
- c. Optimalisasi Kemampuan Fisik: Menyelenggarakan program *Fit to Task* harian guna memastikan setiap penghuni melakukan aktivitas yang sesuai dengan kapasitas fisik dan kondisi kesehatan mereka saat itu.
- d. Dukungan Psikologis dan Mental: Mengadakan seminar kesehatan mental secara tahunan untuk menjaga kesejahteraan emosional serta mencegah depresi atau demensia pada lansia.
- e. Evaluasi Kesehatan Menyeluruh: Memberikan layanan pemeriksaan kesehatan berkala (MCU) dan *Psychological Check-up* (PCU) setiap tahun, lengkap dengan diskusi laporan kesimpulan bersama dokter agar penghuni memahami kondisi kesehatannya.
- f. Edukasi Pola Hidup Sehat: Memberikan pendidikan kesehatan (*Health Education*) dan promosi kesehatan secara rutin untuk mendorong kemandirian lansia dalam menjaga pola makan dan kebugaran.

-
- g. Akses Medis Tanpa Mobilisasi Berat: Menyediakan layanan konsultasi dokter di tempat (*in-house*) sebanyak 4 kali kunjungan per bulan atau sesuai permintaan, sehingga lansia tidak perlu sering bepergian ke luar fasilitas yang dapat menguras energi.
 - h. Penanganan Nyeri dan Darurat: Menyiapkan ketersediaan obat-obatan darurat (*emergency medicine*) dan peralatan medis seperti stetoskop yang selalu siap pakai untuk tindakan pertolongan pertama yang cepat dan tepat.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum pendirian klinik perusahaan di Indonesia adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan.

Klinik perusahaan adalah tempat yang menyediakan pelayanan kesehatan, terutama untuk bidang pelayanan kesehatan kerja. Pelayanan kesehatan kerja ini meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan.

Selain Peraturan Menteri Kesehatan, ada beberapa dasar hukum lain yang berkaitan dengan klinik, yaitu:

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik
8. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024 yang menjamin akses layanan kesehatan aman, terjangkau, serta perlindungan bagi lansia terlanter
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5/823/AS.01.05/VIII/2024 tentang Penunjukan Perusahaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1.4 Ruang Lingkup

1. Program pelayanan kesehatan lansia.
2. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar di *Elderly Care*.

BAB 2

PROFIL RUMAH SAKIT

Rumah Sakit Prima Husada Group didirikan secara perorangan dan berbentuk badan hukum yang bernama PT. Disa Prima Medika yang beralamatkan di Jalan Banjararum Selatan 3, Mondoroko, Singosari, Malang dan di Jalan Surabaya – Malang KM 54, Lemahbang, Sukorejo, Pasuruan yang kegiatan usaha keduanya bergerak di bidang pelayanan kesehatan.

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo berdiri pada 11 Januari 2019 dan telah melayani ratusan ribu pasien. Dalam melayani pasien, kami memposisikan pasien adalah diri kami sendiri, maka kami sangat mengerti semua yang dikehendaki oleh pasien. Layanan yang aman, tepat, cepat dan akurat demi kesembuhan pasien telah menjadi prioritas kami dalam bekerja.

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo memiliki visi menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat. Dalam menjalankan visi tersebut, rumah sakit menetapkan misi memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat; mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien; dan meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit umum swasta tipe C di Kabupaten Pasuruan dengan 180 TT dengan jumlah karyawan 467 orang. Rumah sakit ini sudah terakreditasi “Paripurna” oleh KARS sesuai Standar Akreditasi Kemenkes (STARKES) di Tahun 2022. Rumah sakit ini terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien sejak awal berdiri sesuai dengan salah satu misinya mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.

BAB 3

PELAKSANAAN

3.1 Sasaran

Sasaran dari kegiatan pelayanan terpadu ini adalah *Exclusive Elderly Care Center* yang mempunyai masalah kesehatan akibat atau berhubungan dengan usia lanjut yang memerlukan tempat untuk pertolongan pertama sebelum dilakukan rujukan ke rumah sakit.

3.2 Tempat

Tempat untuk pelaksanaan Klinik Perusahaan ditentukan oleh perusahaan sendiri, namun mengacu pada standarisasi dengan ketentuan:

1. Ukuran ruangan memadai
2. Partisi ruang periksa
3. Tempat cuci tangan
4. Tempat tidur pemeriksaan + *footstep*
5. Lemari obat
6. Lemari file
7. Meja dan kursi dokter
8. Meja dan kursi perawat
9. Papan informasi: berisi jadwal layanan, info penyakit, dsb.
10. Kursi tunggu pasien
11. AC
12. Kulkas kecil (*optional*)

3.3 Alat Medis Dasar

1. Tensimeter: Digital atau air raksa (stetoskop disertakan) untuk memantau tekanan darah.
2. Termometer: *Infrared gun* atau digital untuk mengecek suhu tubuh.
3. Oksimeter (Pulse Oximeter): Untuk mengukur kadar oksigen dalam darah.
4. Penlight: Lampu senter kecil untuk memeriksa pupil mata atau tenggorokan.
5. Timbangan Badan & Pengukur Tinggi Badan: Untuk evaluasi status gizi/BMI.
6. Tabung Oksigen & Regulator: Lengkap dengan masker atau *nasal cannula*.
7. Nebulizer: Untuk membantu lansia yang mengalami serangan asma atau sesak napas.
8. Tandu (Stretcher) atau Kursi Roda: Untuk mobilisasi pasien yang tidak mampu berjalan.

3.4 Pelayanan Medis Dasar

1. Penyakit Kardiovaskular: Pemantauan tekanan darah rutin untuk penderita hipertensi serta deteksi dini gejala serangan jantung atau gagal jantung.
2. Gangguan Metabolik: Kontrol kadar gula darah secara berkala bagi penderita Diabetes Melitus untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.
3. Kesehatan Pernapasan: Penanganan dan pemantauan kondisi seperti PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronis) atau asma melalui pemeriksaan fisik rutin.
4. Masalah Muskuloskeletal: Manajemen nyeri dan keterbatasan gerak pada penderita Osteoarthritis atau Osteoporosis agar tetap dapat beraktivitas (*Fit to Task*).
5. Kesehatan Mental dan Kognitif: Melalui program *Mental Health Seminar* dan *Psychological Check-up* (PCU) tahunan untuk mendeteksi serta menangani gejala Demensia, Alzheimer, atau Depresi pada lansia.
6. Penyakit Infeksi: Pemberian edukasi kesehatan dan pemantauan harian untuk mencegah infeksi saluran kemih (ISK) atau pneumonia yang sering menyerang lansia dengan sistem imun rendah.
7. Manajemen Komorbiditas: Evaluasi risiko kesehatan (*Health Risk Assessment*) bulanan oleh dokter untuk mengelola pasien yang memiliki lebih dari satu penyakit secara bersamaan agar terapi tidak saling bertabrakan.

3.5 Pelayanan Gizi

Pelayanan gizi di Klinik Perusahaan berupa konsultasi dan konseling yang dilakukan oleh dokter pelaksana atau perawat terlatih. Isi konsultasi dan konseling yang diberikan kepada pasien sangat tergantung pada penyakit yang diderita.

1. Promotif
 - a. Menu seimbang
 - b. Akibat kelebihan/kekurangan gizi
2. Preventif
 - a. Pengawasan kelebihan/kekurangan gizi
 - b. Pengukuran status gizi
 - c. Mendeteksi masalah gizi

3. Kuratif

Terapi gizi medis sederhana termasuk bahan makanan penukar sesuai penyakit pasien yang bertujuan agar pasien dapat lebih mandiri dalam penatalaksanaan dietnya, bila tidak dapat melakukan hal tersebut disarankan untuk merujuk.

4. Rehabilitatif

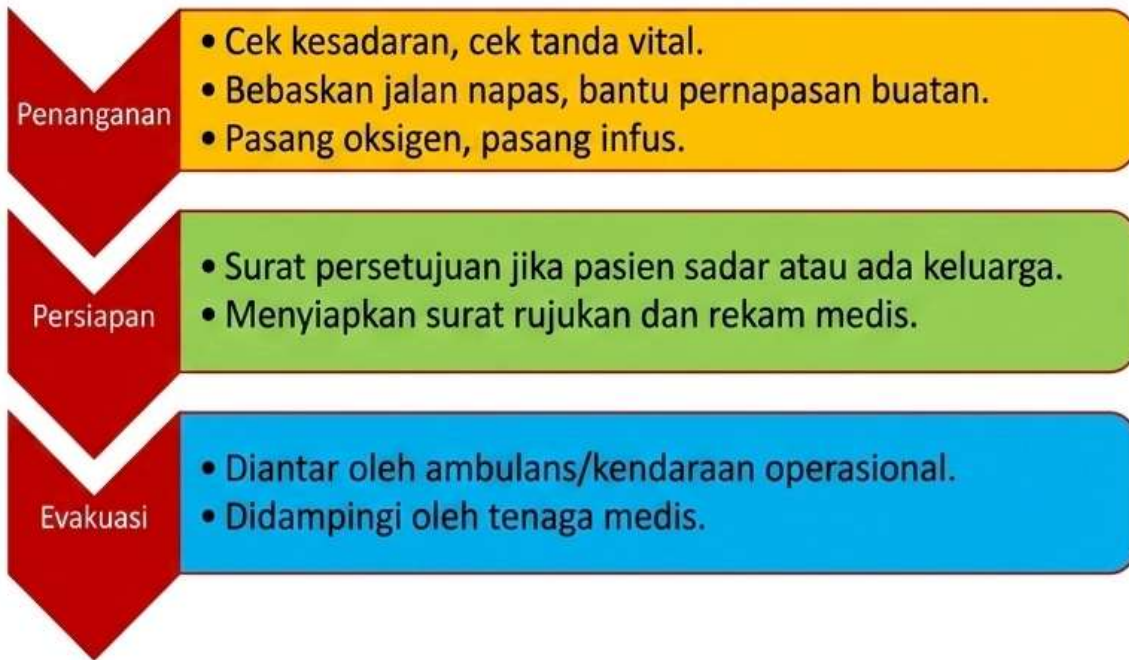
Pemberian nasehat gizi yang sesuai, agar penyakit pasien tidak jatuh pada keadaan yang lebih parah, bila tidak dapat melakukan hal tersebut disarankan untuk merujuk.

3.6 Alur Pelayanan

Alur pelayanan kesehatan terhadap karyawan di Klinik Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu tahap pendaftaran, tahap pemeriksaan dan konsultasi, selesai pemeriksaan.



3.6 Prosedur Rujukan



BAB 4

PENGALAMAN

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan terkait *inhouse clinic* yaitu dengan PT Nestle Indonesia, PT LyondellBasell, PT TriSakti Purwosari Makmus (Purwosari dan Singosari) dan PT Atomization Indonesia. Beberapa program kami bentuk untuk meningkatkan layanan inhouse clinic sebagai berikut:

1. PT. Nestle Indonesia Gempol DC



2. PT. LyondellBasell LyondellBasell Advanced Polyolefins



3. PT. Atomization Indonesia



4. PT. TriSakti Purwosari Makmur (Purwosari)



5. PT. TriSakti Purwosari Makmur (Singosari)



Berikut beberapa program yang dilaksanakan di Inhouse Clinic:

1. Menganalisis resiko kerja di Perusahaan

Dokter yang bertugas wajib menganalisis resiko kerja terhadap Perusahaan dalam tiga zona merah, kuning, hijau dan dapat mencegah kejadian resiko atau meminimalisir resiko kerja.

2. Laporan bulanan

Dokter yang bertugas di Perusahaan setiap bulan membuat laporan bulanan yang sudah disepakati dan di presentasikan pada direktur RS, para kbid dan juga PIC in house clinic

BAB 5

PENAWARAN KERJA SAMA

4.1 Penawaran

Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dibawah naungan PT. Disa Prima Medika yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan memberikan penawaran program Klinik Perusahaan dengan harga **Rp -/bulan** sudah termasuk **PPn dan PPh 23** sebagaimana tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Item	Specification	Schedule	Qty	Remark
A. Manpower					
1	Doctor	1. Hiperkes, 2. STR, 3. SIP, 4. Other training (BTCLS/ACLS - emergency response; first aid; OH training)	22 times visit/month (08.00-16.00) or request	1	1. Include uniform, transportation, BPJS, tax, THR, PPE, etc.; 2. Meals from user; 3. Additional amount for a call IDR/visit/8 hours
2	Nurse	1. Hiperkes, 2. STR, 3. SIPP 4. Other training (BTCLS/ACLS - emergency response; first aid; OH training)	Monday-Saturday; Shift 1: 08.00-20.00; Shift 2: 20.00-08.00	3	1. Include uniform, transportation, BPJS, tax, THR, PPE, etc.; 2. Meals from user; 3. Additional amount for a call IDR/visit/24 hours
B. Program					
1	Health & Safety Promotion/Health Talk		Weekly	1	1. If there are other programs from the vendor, please add them 2. Regular program becomes the responsibility of the doctor as Coordinator and ensures every activity involves the HSE Team.
2	Daily Check-up		Daily		
3	Record & report		Monthly		
4	Medical emergency response		Semesterly		
5	Medical check up (MCU) & Psychological Check up (PCU) - Conclusion		Yearly		

	Report & Discussion				
6	Health education		Yearly		
7	Mental health seminar		Yearly		
C. Clinic equipment & Medicine					
1	Stetoskop		Daily	1	If anything is provided by the vendor at no cost, it can be added
2	Medical Waste (B3)		Daily		
3	Equipment Calibration		Semesterly		
4	Emergency Medicine		Per Pack		
D. Management Fee					
1	Management Fee	6-8% from total manpower; program; clinic equipment	Monthly	1	

4.2 Lampiran daftar Obat

Tabel 1. Daftar Obat

1	Amlodipine		Tab
2	Vit b complex		Tab
3	Allopurinol		Tab
4	Simvastatin		Tab
5	Paracetamol		Tab
6	Cetirizin		Tab
7	Dexanta		Tab
8	Metformin		Tab

4.3 Sistem dan Alur Rekam Medis

1. Struktur Pengarsipan (*The Folder System*)

Gunakan satu *Medical Binder (Ring Binder)* untuk setiap penghuni. Berikan label nama yang jelas dan gunakan pembatas (*divider*) berwarna untuk memisahkan kategori informasi.

-
- a. Warna Merah: Data Darurat & Alergi.
 - b. Warna Biru: Riwayat Medis & Diagnosis Dokter.
 - c. Warna Hijau: Catatan Harian Perawat.
 - d. Warna Kuning: Jadwal & Pemberian Obat.

2. Alur Penyimpanan & Keamanan

- a. Penyimpanan Terpusat: Semua *binder* disimpan di *Nurse Station* dalam rak tertutup untuk menjaga privasi (sesuai kaidah kerahasiaan medis).
- b. Sistem Dokumentasi: Setiap petugas wajib mengisi formulir segera setelah melakukan tindakan (prinsip: *tulis yang dilakukan, lakukan yang ditulis*).
- c. Laporan Serah Terima (Handover): Saat pergantian *shift*, perawat membacakan ringkasan dari catatan manual ini kepada tim berikutnya agar pemantauan tidak terputus.

4.4 Pembayaran Tagihan

Nama Penerima : PT DISA PRIMA MEDIKA
Nama Bank : PT Bank Mandiri Persero Tbk
Cabang, Alamat Bank: KK Malang Sutoyo, Jl. Letjen Sutoyo No. 18-20,
Bunulrejo, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa
Timur 35141
Nomor Rekening : 144-0055533324
Kode Swift / IBAN : BMRIIDJA

4.5 PIC (*Person in Charge*) Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

- 1. Nama : Wahyu Rahmatun Nisa
Jabatan : Humas & Marketing Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
No. HP : 0813 1557 4065

BAB 6

PENUTUP

Demikian pemaparan mengenai fasilitas dan mekanisme pelaksanaan Klinik Perusahaan. Niat tulus dan profesionalisme yang mendasari terjalinnya kerjasama antara pihak rumah sakit dengan perusahaan harus diarahkan pada kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk kepentingan karyawan dari perusahaan. Kesungguhan dan tekad, serta prinsip yang saling menguntungkan di antara pihak terkait akan berdampak pada kepentingan pelayanan kepada peserta kegiatan Klinik Perusahaan ini.

Sukorejo, 13 Mei 2026

Direktur RS Prima Husada Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S. Kep., M. Kep